

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Salah Bounider Constantine 03

Faculté de médecine Constantine



ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025

PROCESSUS TUMORAL

DR A.BENSEGUENI

bensegueniaf@gmail.com

LABORATOIRE D'ANATOMOCYTO PATHOLOGIQUE

EHS Daksi Constantine

PROCESSUS TUMORAL

OBJECTIFS DU COURS

- **Définir** le processus tumorale.
- **différencier** entre les tumeurs bénignes et tumeurs malignes
- **concevoir** les caractères moléculaires des tumeurs.
- **connaître** les pseudotumeurs.

.

PLAN DU COURS

I – INTRODUCTION,GÉNÉRALITÉS.

II-Pseudotumeur tumeur

III-Tumeurs bénignes et Tumeurs malignes

A/ Caractères fondamentaux de la néoplasie

Caractères évolutifs:

Tumeur de potentiel évolutif intermédiaire (Borderline)

B/Caractères histologiques et cytologiques

Tumeurs bénignes

Caractères cytologiques de malignité

C/ Différenciation cellulaire tumorale

Degré de différenciation

D/ Caractère moléculaire de la cellule cancéreuse

IV- CONCLUSION.

I-Introduction : Tumeur = Néoplasie = Néoplasme :

Est une néoformation tissulaire excessive et anormale dont la croissance échappe à l'homéostasie de l'organisme, ayant tendance à persister et à croître, témoignant de son autonomie biologique.

Le processus cancéreux:

phénomène fatal et irréversible correspondant à une série d'évènements qui se suivent c'est une maladie multi factorielle caractérisée par le développement d'un clone cellulaire anormal échappant aux lois de l'homéostasie.

L'histoire naturelle d'un cancer est divisée schématiquement en plusieurs étapes :

§ La transformation cancéreuse d'une cellule ;

§ L'expansion clonale de la cellule cancéreuse ;

§ La croissance de la masse tumorale qui devient cliniquement détectable et l'invasion locale ,locorégionale , et a distance par le tissu cancéreux (métastases).

II-Pseudotumeur tumeur

Sont des lésions qui cliniquement et ou radiologiquement ressemblent à des tumeurs mais en réalité elles résultent de processus non tumoral tels que l'inflammation la fibrose ,anomalies vasculaires ou des malformations.

Pseudo - tumeurs inflammatoires

- Granulome à corps étrangers
- Botryomycome
- Chéloïde

Dystrophie : sont des anomalies tissulaires acquises, secondaires à un trouble métabolique

- goitre thyroïdien
- Dystrophie mammaire
- Hypertrophie de la prostate

Malformations

- Choristome
- Hamartome

III-Tumeurs Bénignes et Malignes

A/Caractères évolutifs

a/Tumeurs bénignes:

- ü Développement local ,Restent localisées, bien limitées, circonscrites,
- ü Refoulent les tissus préexistants
- ü Peu de retentissement sur l'état général
- ü Ne récidive pas après Traitement.
- ü GRAVE par leur Localisation ou de désordres Métaboliques.

b/Tumeurs malignes: cancers

- ü Mal limitées, une croissance rapide.
- ü Franchit la membrane basale d'un revêtement épithélial
- ü Capable de détruire et d'envahir les tissus préexistants et infiltre les tissus sous-jacents et a distance :**les métastases.**
- ü Les tumeurs malignes ont tendance à récidiver après éradication locale.
- ü **L'évolution**, en l'absence de traitement, se fait spontanément vers la mort.

Tumeur de potentiel évolutif intermédiaire

•Tumeurs bénignes ayant certains caractères d'agressivité

•Fibromatoses

Aspect histologique bénin

Mal limitée, infiltrent les tissu voisins Tendance à la récidive .

Exp :Tumeur Desmoïde de l'intestin grêle

• **Adénomes** du colon ou du rectum: • Sont des lésions précancéreuses ou tumeurs à malignité potentielle

Certains cancers (infiltrants) ont une évolution locale sans donner de métastases:
carcinome basocellulaire.

B/Caractères histologiques et cytologiques

La Microscopie Indispensable pour confirmer la nature bénigne ou maligne d'une tumeur

Tumeurs Bénignes

- Reproduit fidèlement le tissu d'origine
- Conserve l'architecture du tissu – Pas d'anomalies cyto-nucléaires – Pas de mitoses atypiques
- Pas d'infiltration des tissus voisins
- Pas d'embolies – Pas de stroma tumoral.

Tumeurs Malignes

- Désorganisation architecturale du tissu
- Anomalies cyto-nucléaires de malignité.
- Infiltration des tissus voisins (emboles)
- Stroma réaction

C/Différenciation cellulaire

Le **degré** de ressemblance histo-cytologique de la cellule tumorale/ au tissu d'origine

La différenciation peut être :

- **Bonne** : ressemblance de façon homogène au tissu normal (tumeur bien différenciée).
- **Faible** : ressemblance peu marquée ou focale (tumeur peu différenciée).
- Cancer **anaplasique** : aucune différenciation.
- Carcinome **indifférencié** : différenciation épithéliale mais sans que l'on puisse dire si elle est malpighienne ou glandulaire.

Bénignité et malignité

Tumeurs bénignes	Tumeurs malignes
Bien limitée	Mal limitée
Encapsulée	Non encapsulée
Histologiquement semblable au tissu d'origine	Plus ou moins semblable au tissu d'origine
Cellules régulières	Cellules irrégulières (cellules cancéreuses)
Croissance lente	Croissance rapide
Refoulement sans destruction des tissus voisins	Envahissement des tissus voisins
Pas de récurrence locale après exérèse complète	Récurrence possible après exérèse supposée totale
Pas de métastase	Métastase(s)

D/Caractères moléculaires de la cellule cancéreuse

Le cancer est une pathologie de l'ADN.

phénomène irréversible au cours duquel la cellule transmet ses anomalies génétiques à la descendance formant un clone cellulaire qui va acquérir de plus en plus d'anomalies aboutissant à la résistance et à la progression de la néoplasie cellulaire.

- rupture permanente de l'équilibre entre les signaux intracellulaires :
 - Activation de voies stimulatrices
 - Suppression des voies inhibitrices
- La coexistence de plusieurs événements est nécessaire à la transformation cancéreuse.
- L'activation de nouveaux oncogènes se poursuit tout au long de la progression tumorale : processus multi-étage.
- Le génome des cellules tumorales acquiert des allèles mutants de proto-oncogènes, de gènes suppresseurs de tumeur et de gènes contrôlant l'intégrité de l'ADN.
- La conséquence est l'acquisition de nouvelles propriétés, dont la capacité de :
 - Générer leurs propres signaux mitogènes.
 - Résister ou d'échapper aux signaux externes d'inhibition de la croissance.
 - Proliférer sans limite (immortalisation).
 - Constituer une néovascularisation (angiogenèse).

IV- CONCLUSION

La pathologie **tumorale** présente un problème de **santé publique** en raison du taux de morbi mortalité qu'elle engendre.

Les cellules cancéreuses initiales présentent une capacité à se **propager (métastaser)** depuis leur localisation primitive dans tout l'organisme.

La classification des tumeurs est fondée sur leur tissu d'origine, leur type histologique, et leur degré de différenciation.

Le pathologiste joue un rôle dans: Le dépistage , Le diagnostic , Le pronostic, traitement .

